EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 83425
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-29 08:42:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JUAN ANTONIO ELGUETA MERCADO			**RUN**	: 3.898.036-K
F.Nac	: 17-10-1937	**Edad**	: 86 AÑOS, 6 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: V.HONDO 21 MAYO 979			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 968029532		
Fecha Ingreso	: 2024-04-18	**Fecha Egreso**	: 2024-04-29 08:42:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. ACV isquémico parietal izq y frontoparietal izq. Obs. Cardioembólico.
2. Neumonía Aspirativa tratada Tazo 7/7
3. Delirium en mejoria
4. Epilepsia
5. Antec: Ca vesical, HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes descritos, previamente autovalente, ultima vez visto bien el dia lunes, es encontrado en domicilio por familiar el dia miercoles quien refiere encontrar en el piso, desorientado, afásico, con imposibilidad de seguir órdenes simples. Al ingreso en SU Presenta mirada fija hacia la izquierda, persiste con paresia braquio crural derecha y afasia expresiva con desviación de comisura labial hacia la derecha. se recibe tac de cerebro con focos de isquemia de origen microangiopatico, con cuadro de hora de inicio no precisable por lo que se decide ingreso a sala de medicina para continuar manejo y estudio, durante su evolución presenta quiebre clínico con cuadro infeccioso respiratorio completando esquema antibiótico con tazo durante 7 días, con evidente resolución clínica, recuperando progresivamente déficit motor con mejoria en fluidez del lenguaje

PLAN DE MANEJO:

KNT resp y motora
Control en Poli de neuro

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen papilla
2. LEVETIRACETAM COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
3. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 2 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
4. ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL

5. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
6. QUETIAPINA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
8. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL

EXÁMENES Y RESULTADOS

27/4/24
Creatinina : 0,90 mg/dl 0,66 - 1,25
Clearence Calculado(MDRD) : 80,01 ml/min/1,73 | > 60
Proteina C Reactiva : 59,6 * mg/L
Sodio (Na) : 141,00 mmol/L 135,00 - 145,00
Potasio (K) : 3,80 mmol/L 3,50 - 5,50
Cloro (Cl) : 109,00 * mmol/L 96,00 - 106,00
25/04/24: Uremia 25 ELP 141/3.50/108 PCR 131/4 creat 0.8
Hemocultivos negativos
23/04/24: Glic 113 creat 0.80 MDRD 91 PCR 130 ELP 141/3.60/109; leuc 9200 Hb 12.4 Hto 35.0 Plaq 168000 PCT 0.36
CSB negativo
TAC de cerebro 22/4/24 imagen hipodensa de aspecto agudo frontoparietal izq y otra de mayor tamaño parietal izq con características subaguda
TAC de torax. Focos de neumonia probablemente aspirativa especialmente en lob inferior der. hay una zona algo mas densa de aspecto nodular

Control en: 10 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO